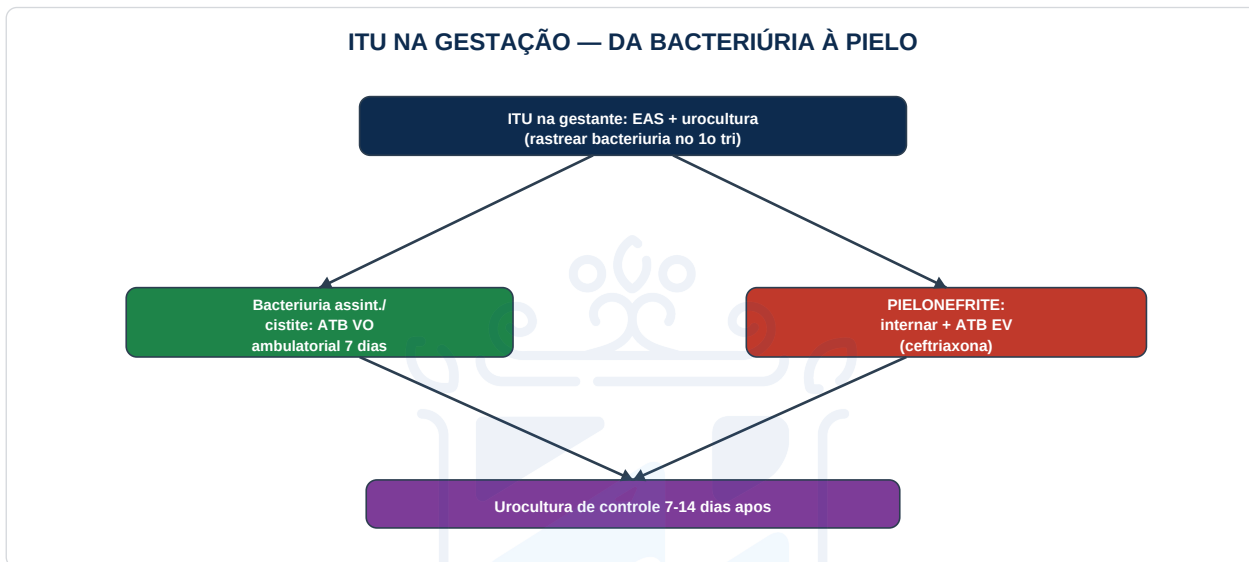


ITU NA GESTANTE — DA BACTERIÚRIA À PIELO

FLUXOGRAMA — CLASSIFICAR E TRATAR



DEFINIÇÃO E RASTREAMENTO

O QUE É

- Infecção bacteriana do trato urinário na gestação: bacteriúria assintomática, cistite aguda ou pielonefrite
- Rastreamento: UROCULTURA de rotina no 1o trimestre (ou na 1a consulta pré-natal)
- Positivo: ≥ 100.000 UFC/mL (MESMO SEM SINTOMAS)
- Na gestante, a bacteriúria assintomática DEVE ser tratada (risco de pielonefrite e parto prematuro)

CLASSIFICAÇÃO CLÍNICA

Forma	Quadro
Bacteriúria assintomática	Sem sintomas urinários + urocultura positiva (≥ 100.000 UFC/mL)
Cistite aguda	Disúria, polaciúria, urgência miccional; SEM febre ou dor lombar
Pielonefrite aguda (grave)	Febre ≥ 38 , dor lombar, náuseas/vômitos, sinais sistêmicos; considerar obstrução

DIAGNÓSTICO

EXAMES

- EAS (urina tipo 1): leucocitúria, nitrito positivo
- UROCULTURA + antibiograma (antes do antibiótico sempre que possível)
- Imagem (USG/RM) em exceção: suspeita de obstrução/cálculo/complicação
- Na pielonefrite: hemograma, função renal, e considerar lactato/hemoculturas se sinais de sepse

TRATAMENTO — BACTERIÚRIA E CISTITE

Rx AMBULATORIAL, 7 DIAS, VO

Bacteriúria assintomática: TRATAR SEMPRE (7 dias)
Nitrofurantoína 100 mg VO 6/6h ou 12/12h — EVITAR após 36 semanas (risco de hemólise neonatal)
Cefalexina 500 mg VO 6/6h
Amoxicilina + Clavulanato 500/125 mg VO 8/8h
Cistite aguda: mesmo esquema; ajustar conforme antibiograma
Controle de cura: urocultura 7-14 dias após o tratamento

TRATAMENTO — PIELONEFRITE (INTERNAÇÃO)

Rx ATB ENDOVENOSO

Internação hospitalar OBRIGATÓRIA + hidratação venosa
Ceftriaxona 1 g IV 1x/dia OU Ampicilina + Gentamicina
Após melhora clínica (48-72h): completar 10-14 dias com ATB VO
Se obstrução por cálculo / compressão ureteral extrínseca: contatar UROLOGISTA para derivação urinária
Vigiar sepse e trabalho de parto prematuro

ANTIBIÓTICOS CONTRAINDICADOS / RECORRÊNCIA

ATENÇÃO

- CONTRAINDICADOS na gestação: QUINOLONAS (ciprofloxacino), TETRACICLINAS
- Sulfametoxazol-trimetoprim: evitar principalmente no 1o e 3o trimestres
- Nitrofurantoína: evitar após 36 semanas (e próximo ao termo)
- Recorrência: considerar profilaxia (ex.: nitrofurantoína 100 mg à noite)
- Se não tratada: trabalho de parto prematuro, baixo peso, sepse materna, pielonefrite

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Gestante ___ semanas com ITU: ___ (bacteriúria/cistite/pielonefrite). Febre/dor lombar: ___.
- EAS/urocultura: ___; função renal: ___; sinais de sepse: ___.
- Conduta: ATB VO (cefalexina/nitrofurantoína) ou EV (ceftriaxona) + internação se pielonefrite.
- Solicito serviço com obstetrícia/UTI se sepse; avaliar urologia se obstrução.

Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Gestante de 12 semanas, assintomática, urocultura de rastreio com 100.000 UFC/mL de *E. coli*. Conduta?

- A) Não tratar, pois é assintomática
- B) Tratar com antibiótico por 7 dias (bacteriúria assintomática na gestante deve ser tratada)
- C) Repetir a urocultura em 3 meses
- D) Tratar apenas se surgirem sintomas
- E) Iniciar ciprofloxacino

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual antibiótico é CONTRAINDICADO no tratamento de ITU na gestante?

- A) Cefalexina
- B) Ciprofloxacino (quinolona)
- C) Amoxicilina-clavulanato
- D) Nitrofurantoína (antes de 36 semanas)
- E) Fosfomicina

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Gestante com febre, dor lombar e náuseas. Diagnóstico e conduta?

- A) Cistite — tratamento ambulatorial oral
- B) Pielonefrite aguda — internação e antibiótico endovenoso (ceftriaxona)
- C) Bacteriúria assintomática — não tratar
- D) ITU baixa — nitrofurantoína e alta
- E) Apenas hidratação

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Por que se deve evitar nitrofurantoína próximo ao termo (após 36 semanas)?

- A) Por ineficácia contra *E. coli*
- B) Pelo risco de hemólise neonatal
- C) Por causar malformação cardíaca
- D) Por ser teratogênica no 1º trimestre
- E) Por reduzir a contração uterina

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Após tratar ITU na gestante, qual a conduta de controle?

- A) Nenhuma; alta definitiva
- B) Urocultura de controle 7-14 dias após o tratamento
- C) Repetir antibiótico por mais 30 dias
- D) Tomografia de vias urinárias
- E) Cistoscopia

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

Na gestante, a bacteriúria assintomática (≥ 100.000 UFC/mL) DEVE ser tratada (7 dias), pois reduz o risco de pielonefrite e de parto prematuro — diferente da mulher não gestante.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

Quinolonas (ciprofloxacino) e tetraciclins são contraindicadas na gestação; SMX-TMP deve ser evitado no 1o e 3o trimestres; nitrofurantoína é evitada após 36 semanas. Cefalexina e amoxi-clav são seguras.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Febre + dor lombar + náuseas/vômitos = pielonefrite aguda na gestante: internação obrigatória com antibiótico EV (ceftriaxona), hidratação e vigilância de sepse/parto prematuro.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

A nitrofurantoína é evitada próximo ao termo (após 36 semanas) pelo risco de hemólise neonatal (anemia hemolítica no RN, especialmente com deficiência de G6PD).

QUESTÃO 5 → Resposta: B

Após o tratamento da ITU na gestante, faz-se urocultura de controle 7-14 dias depois para confirmar a cura; recorrências podem indicar profilaxia.

SM24
Suporte ao Plantão Médico